Les déterminants de la politique vaccinale

Plan

1. Introduction.
2. De l'inoculation à la vaccination.
3. Edouard Jenner et la vaccination antivariolique.
4. Les sociétés devant la vaccination.
5. Les vaccins antiviraux et la vaccination antipoliomyélitique.
6. La multiplication des vaccins.
7. L'attitude actuelle du citoyen vis-à-vis des vaccins, craintes et fantasmes
8. De la santé publique à la santé globale.
9. Ethique et politique vaccinale.

1. Introduction.

- **La vaccination est un procédé consistant à introduire un agent extérieur (le vaccin) dans un organisme vivant afin de créer une réaction immunitaire positive contre une maladie infectieuse.**

- **La substance active d'un vaccin est un antigène dont la pathogénicité est atténuée afin de stimuler les défenses naturelles de l'organisme (le système immunitaire).**

1. Introduction.

- La réaction immunitaire primaire permet en une mise en mémoire de l'antigène présenté pour qu'à l'avenir, lors d'une vraie contamination, l'immunité acquise puisse s'activer de façon plus rapide et plus forte.

- **Stratégie de santé publique** communément admise, la vaccination a hérité d’une histoire héroïque substituant la prévention au traitement.

1. Introduction.

- L'OMS estime que la vaccination est l'une des interventions sanitaires les **plus efficaces et les plus économiques.**

Elle a permis d'éradiquer la variole, de réduire de 99 % à ce jour l'incidence mondiale de la poliomyélite, et de faire baisser de façon spectaculaire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole.

1. Introduction.

- Les vaccins représentent aujourd'hui un outil privilégié pour les programmes visant
  - la disparition de fléaux (Maladies transmissibles) et
  - la résolution des inégalités de santé nationales et internationales.

2. De l’inoculation à la vaccination.

- La variole, maladie hautement contagieuse

- Au début des années cinquante, 50 millions de cas sont recensés chaque année.

- Facile à diagnostiquer avec ses pustules sur tout le corps, hautement contagieuse et fournissant, une protection à ceux qui survivent.

2. De l’inoculation à la vaccination.

Des rituels prophylactiques ont été décrits en plusieurs points du globe, mais c’est en Chine qu’on identifie les traces d’une «variolisation » préventive, vers le XVIe siècle.

- Une première méthode consistait à insuffler dans les narines une poudre de pustules.

- La deuxième procédait par « inoculation » de pus varioleux sous la peau avec une aiguille.

2. De l’inoculation à la vaccination.

- Il s'agissait d’inoculer une forme qu’on espérait peu virulente.

- Ce dernier procédé suivit la route de la soie dans l’Empire ottoman, pour être importée depuis Constantinople en Occident au début du XVIIème siècle grâce à Lady Mary Montaigu, femme de l’ambassadeur d’Angleterre, à l’issue d’un séjour en Turquie en 1718.

- Le risque n'était cependant pas négligeable : le taux de mortalité pouvait atteindre 1 ou 2 %.

3. Edouard Jenner et la vaccination antivariolique.

- La possibilité d'immuniser les humains de la variole en leur inoculant la variole des vaches (cow pox), qui était présente sur les pis des vaches a été réalisé en 1796 par le médecin anglais **Edward Jenner, conférant une « immunité croisée » contre la variole.**

3. Edouard Jenner et la vaccination antivariolique.

- Le 14 mai 1796, il inocula à un jeune enfant âgé de 8 ans, du pus prélevé sur la main d’une fermière infectée par la vaccine, ou variole des vaches.

- Trois mois plus tard, il inocula la variole à l'enfant qui s'est révélé immunisé.

- Cette pratique s'est répandue progressivement dans toute l'Europe puis dans tous les états et aboutira à l’éradication de la maladie.

Louis Pasteur (1822-1895)
« père des vaccins modernes ».

- C’est le succès du vaccin contre la rage qui cimenta l’alliance de l’État français et de la recherche médicale et fut à l’origine de la construction de l’Institut Pasteur.

- La 1ère vaccination humaine fut celle d'un enfant contre la rage le 6 juillet 1885.

- Il faut remarquer que contrairement à la plupart des vaccinations, cette dernière fut effectuée *après l'exposition au risque – ici, la morsure par un chien enragé et non*.

4. Les sociétés devant la vaccination.

- Cependant les populations suivirent inégalement le mouvement. Elles manifestèrent souvent de l'incrédulité et de la méfiance devant l'innovation. Le philosophe Kant refusait « *l'animalisation de l'humanité* ».

- Les réponses de la société à la vaccination diffèrent selon les us et coutumes des populations, la conjonction historique et politique ainsi que la situation économique du pays au moment de la mise en place de la vaccination.

5. Les vaccins antiviraux et la vaccination antipoliomyélitique

- À partir de 1949, des **milieux vivants cellulaires permettent de cultiver les virus.**

- La poliomyélite est une maladie virale qui tue et estropie les **enfants d'âge scolaire.**

- Confrontés à l'épidémie de 1952, les dirigeants américains font le choix du type de vaccin tué injectable préparé par **Jonas Salk.**

5. Les vaccins antiviraux et la vaccination antipoliomyélitique

- **Le premier essai clinique véritablement de masse se déroule dans les villes américaines, entre 1954 et 1956, dans un climat électrique.** ***Cet essai fut possible grâce à la March of Dimes, une gigantesque collecte des petites pièces de ce nom, qui permit le financement du premier grand essai clinique sur des millions d'enfants avec le vaccin tué de Jonas Salk***

- Les États-Unis prenaient la tête de la compétition internationale en matière de vaccins, même après la fin des essais, plusieurs morts attribuées à l'incurie d'une des firmes chargées de produire le vaccin en quantité

5. Les vaccins antiviraux et la vaccination antipoliomyélitique

- Face au grand succès américain, l'Union Soviétique opta en 1955 pour le vaccin vivant atténué, administré par voie orale,

- d'**Albert Sabin, américain d'origine russe, qui disposa ainsi d'un terrain vierge pour des essais d'une ampleur comparable à ceux de son rival Salk.**

- **Lequel est le bon ? Le débat fait rage avant d'établir les avantages et inconvénients respectifs.**

5. Les vaccins antiviraux et la vaccination antipoliomyélitique

- **Dans les années qui suivirent, les États-Unis se ravisèrent et jugèrent le vaccin Sabin plus efficace et plus facile à administrer.**

- **Finalement, dans la perspective de l'éradication, et au regard des avantages et inconvénients de chaque vaccin, il y a aujourd'hui consensus sur leur complémentarité..**

6. La multiplication des vaccins.

- Le but principal des vaccins est d'induire la production par l'organisme d'anticorps, agents biologiques naturels de la défense du corps vis-à-vis d'éléments pathogènes identifiés.

- Un vaccin est donc spécifique à une maladie mais pas à une autre.

- Cette production d'anticorps diminue progressivement dans un délai plus ou moins long, fixant ainsi la durée d'efficacité du vaccin.

- Elle est mesurable et cette mesure peut être utilisée dans certains cas pour savoir si le sujet est vacciné efficacement (vaccin anti-hépatite B et anti-tétanos en particulier).

6. La multiplication des vaccins.

- À la fin du XIXe siècle, avec le **développement de la microbiologie**, il devient possible d'isoler chez les malades, des germes, de les cultiver et de les modifier en laboratoire, pour atténuer leur virulence et les inoculer à des fins prophylactiques.

- Il reste que choléra, peste, tuberculose, typhus plus tardivement, ont trouvé leur vaccin.

6. La multiplication des vaccins.

- Pour d'autres (diphtérie, tétanos) il aura fallu la découverte des **anatoxines.**

- Grâce aux **cultures cellulaires**, des vaccins s'adressent à d'autres affections virales de l'enfance : rougeole (1962), oreillons (1967), rubéole, (1969) varicelle (1974).

- **Le vaccin inactivé** contre la grippe, lui, lancé dans les années 1970, est plutôt destiné aux personnes âgées, à l'immunité fragile (jusqu'à ce que la perspective d'une pandémie en 2009 fasse réviser les indications).

6. La multiplication des vaccins.

- **Des vaccins anticancéreux** qui s'adressent à des infections induisant les cancers ont également vu le jour.

- Le premier a été le vaccin contre le virus de **l'hépatite B**, responsable de **tumeurs du foie**.

- Il a été le premier **vaccin** recombinant, produit par **génie génétique.**

- Le vaccin contre les cancers du **col de l'utérus** est dirigé contre les **papillomavirus (HPV),** source d'infections sexuellement transmissibles.

- Le vaccin **contre *Helicobacter pylori*** *vise la prévention du*

6. La multiplication des vaccins.

- Un vaccin **contre les rotavirus**, des diarrhées infantiles qui sont une cause majeure de mortalité infantile dans le tiers-monde, est enregistré.

- Des vaccins **anti-méningocoque** et **anti-pneumocoque** sont disponibles.

- Un vaccin **anticonceptionnel** est à l'essai.

- Le calendrier vaccinal s'enrichit et des formules de **vaccins multi-conjugués** voient le jour.

6. La multiplication des vaccins.

- **Le programme élargi de vaccination, en Algérie (PEV)**
- Les objectifs (PEV) visent l'atteinte d'
  - un taux national et par wilaya de couverture vaccinale d'au moins 95 % pour tous les vaccins,
  - l'éradication de la poliomyélite,
  - l'élimination du tétanos néonatal,
  - l'élimination de la rougeole, l'élimination de la diphtérie, ainsi que
  - la réduction de la mortalité et de la morbidité des infections dues au virus de l'hépatite B.
- Actualisation régulière du calendrier vaccinal (2014).

7. L’attitude actuelle du citoyen vis-à-vis des vaccins, craintes et fantasmes

- Ces dernières décennies, le nombre des vaccins disponibles n’a cessé d’augmenter, et l’agenda vaccinal idéal de se compliquer.

- Dans ce nouveau contexte, la position des sociétés, vis-à-vis des vaccins, a changé.

7. L’attitude actuelle du citoyen vis-à-vis des vaccins, craintes et fantasmes

- Les citoyens ils sont moins enclins à accepter un agenda préformé et souhaitent de plus en plus un vaccin qui tienne compte de leur style de vie et de leurs prédispositions à telle ou telle maladie.

- Même si la menace des maladies infectieuses est toujours perçue, les citoyens ont une **préoccupation de sécurité** et revendique un **risque zéro**, corollaire du principe de précaution.

7. L'attitude actuelle du citoyen vis-à-vis des vaccins, craintes et fantasmes

- La vaccination ne cesse de susciter de vives et récurrentes polémiques au sein de l'espace public.

- **En Algérie,** le citoyen devient de plus en plus méfiant vis-à-vis de la vaccination en général lorsqu'il lit dan la presse en 2010, l'ouverture du procès lié au **scandale des vaccins périmés** de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) ou encore que **2 millions de doses de DTCoq** importées de Cuba ont été transférés vers un dépôt alors que la chaîne du froid était rompue et également que les **vaccins H1N1 importés** au moment où cette grippe **faisait des dégâts** dans le monde étaient **non conformes.**

7. L'attitude actuelle du citoyen vis-à-vis des vaccins, craintes et fantasmes

- En septembre 2016, la décision de **relever le DG de l'IPA de ses fonctions** serait liée aux conclusions de l'enquête diligentée, suite au décès, deux mois auparavant de deux nourrissons, après avoir été vaccinés au Pentavalent.

- Le retrait de cette forme de présentation (pentavalent) tout en disculpant le vaccin est à l'origine de l'échec total de la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole qui en est suivie.

7. L’attitude actuelle du citoyen vis-à-vis des vaccins, craintes et fantasmes

- En matière de vaccins, il s’agit donc désormais d’informer, voire de restaurer la confiance dans les vaccins actuellement existants.

- L’acceptabilité sociale se pose, par conséquent, comme une problématique contemporaine dans les sociétés face à la défiance croissante à l’égard des politiques de santé publique.

8. De la santé publique à la santé globale.

- Après une **période de désaffection** relative liée à l'emploi **massif des antibiotiques**, les vaccins réapparaissaient comme une **ligne de défense prioritaire**, devant l'échappement des agents pathogènes aux traitements et l'apparition de nouvelles niches infectieuses.

- À la fin de la 2ème guerre mondiale, devant l'**asymétrie** choquante entre pays pauvres et nantis, l'OMS choisit le **vaccin de masse** comme la meilleure stratégie face aux maladies infectieuses.

9. Ethique et politique vaccinale.

- La politique vaccinale s'inscrit dans une activité de protection de santé publique.
- Elle est de la responsabilité de l'État.
- Pour la définir, l'État s'appuie sur l'expertise pluridisciplinaire d'un Comité Technique des Vaccinations.

9. Ethique et politique vaccinale.

- L'élaboration de la politique vaccinale doit tenir compte
  a. des avancées techniques,
  b. de l'évolution des caractéristiques épidémiologiques des maladies,
  c. des recommandations internationales,
  d. de l'évaluation du rapport bénéfices/risques mais aussi du rapport coût/efficacité de chaque vaccin, enfin
  e. de l'organisation du système de soins et de prévention dans le pays.

9. Ethique et politique vaccinale.

- L'obligation vaccinale a une justification essentiellement historique.

- Quand une vaccination s'avérait être un moyen pour éviter la propagation d'une épidémie, les décideurs politiques au **titre de la protection collective de la santé** ont pris des mesures contraignantes telles que **l'obligation vaccinale**.

- L'obligation vaccinale peut concerner par ailleurs des voyageurs pour les protéger d'une contamination éventuelle en fonction d'une destination: l'Afrique subsaharienne ou le pèlerinage à la Mecque pour la fièvre jaune.

9. Ethique et politique vaccinale.

- Qui dit **obligation vaccinale** dit **moyens** de faire respecter l'obligation (ex : refus d'inscription à la crèche ou à l'école).

- **Les vaccins sont considérés comme une contribution majeure au recul des maladies infectieuses au XXe siècle :**

- ils ont permis un essor démographique sans précédent dans le monde, même s'il existe encore un décalage important entre les pays.

Conclusion

- Dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses, les **vaccins** ont une **place prépondérante**. Ils sont l'un des **moyens de prévention les plus efficaces.**

- La vaccination apparaît comme un procédé d'immunisation aisé à déployer collectivement, **économique et efficace**

- L'histoire de la vaccination antivariolique est un épisode incontournable pour restituer la genèse de la santé publique.

Conclusion

- **L'universalisation de la vaccine** joua un grand rôle dans **l'essor démographique** du siècle dernier

- Les vaccins sont d'une certaine **façon victimes de leur succès,** la population ayant souvent **oublié jusqu'au nom des maladies** contre lesquelles leurs enfants sont vaccinés et n'étant interpellée à leur propos qu'à travers la médiatisation d'effets indésirables attribués aux vaccins sans l'analyse critique.

- La dimension éthique visant à protéger la collectivité tout en respectant l'individu est devenue indispensable, elle ne peut qu'être dynamique et évoluer dans le temps.

Merci pour votre attention